

Información Paciente

Nombre : Juan Carlos Aravena Salinas
Edad : 66a 1m 23d
Dirección : Abogado 0654 Bernardo Leighton

Rut : 8.227.951-2
Fecha Nacto: 15/12/1959
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 2529245
Sexo : Masculino
Teléfono : 9 7984 5151

N° Epicrisis
471232

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 05/01/2026 00:55

Días Estadía: 33

Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Egreso : 07/02/2026 07:02

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

compromiso de conciencia

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Nombre: Juan Carlos Aravena Salinas
RUT: 8.227.951-2
Edad: 66 años
FI HSR: 04/01/26
FI UPC: 05/01/26

Antecedentes

- Médicos: DHC en estudio
- Medicamentos: furosemida, hidroclorotiazida
- Alergias: (-)
- Cirugías: (-)
- Hospitalizaciones: (-)
- Hábitos: TBQ (+) 10 cigarrillos al día; OH suspendido hace 3-4 meses, antes consumo diario; drogas (-)
- Social: autovalente

Anamnesis

Paciente con antecedentes descritos, es llevado al servicio de urgencia de HSR el 04/01 en la noche en SAMU, luego de ser encontrado por familiares comprometido de consciencia, con incontinencia urinaria y tembloroso. SAMU lo encuentra taquicárdico, taquipeico, hipertenso y febril hasta 39°C.

Al ingreso en el servicio de urgencia se describe vigil al estímulo táctil, con salida de secreción purulenta por oído derecho. Evaluado por neurología, que describe presencia de rigidez de nuca y menor movilidad braquiocrural izquierda.

Se realiza estudio con TAC de cerebro, que muestra ocupación de celdas mastoideas izquierdas. Se sospecha meningitis bacteriana secundaria a foco ótico, por lo que se inicia tratamiento antibiótico en dosis meníngeas.

Evoluciona con estatus convulsivo (2 episodios convulsivos presenciados), por lo que se decide manejo avanzado de la vía aérea y carga con levetiracetam, por lo que ingresa a UPC.

Microbiología

- HC I y II: creciendo cocáceas G(+) en cadena a las 11 horas
- UC: pendiente

Fecha Epicrisis : 07/02/2026 07:53

Página 1 de 3

Fecha Última Actualización: 07-02-2026 7:53:10

Página 2 de 3

Imágenes

-TAC de cerebro (evaluado por neurología): ocupación de celdas mastoideas izquierda

Diagnósticos de ingreso

(1)Compromiso de consciencia

-Estatus convulsivo

-Obs. meningitis bacteriana secundaria a otitis media aguda izquierda

(2)Otitis media aguda izquierda

(3)Acidosis metabólica con anion gap aumentado

-Obs. cetoacidosis diabética

-Hiperlactatemia por insuficiencia hepática

(4)Daño hepático crónico descompensado, obs. secundario a OH

-Coagulopatía

Evolucion en UCI:

HDN: con requerientos de noradrenalina de forma intermitente. Buena perfusion clinica. Tras evolucion prolongada en condicion de critico cronico, y dado pronostico neurologico ominoso, se decide no reinicio de drogas vasoactivas.

Respiratorio: ventilacion mecanica prolongada por compromiso de conciencia persistencia. Se realiza TQT logrando salida a filtro. Actualmente en filtro, sin necesidad de conexion a ventilacion mecanica, con buena mecanica.

Neurologico: se aísla en LCR neumococo penumoniae MS. Recibe terapia con ceftriaxona con buena respuesta clinica, pero presenta compromiso de conciencia persistente pese a manejo de infeccion. Se realiza TAC y angiotac de cerebro que evidencian extenso infarto bilateral, mayor a derecha con fenomenos vasculiticos en angiotac, secundarios a meningitis por neumococo. Se corroboran hallazgos con RNM. Pronostico neurologico ominoso, con nulo potencial de rehabilitacion. Se conversa con familia y decide proporcionalizar cuidados. NO RCP SI PCR, NO TERAPIAS DE REEMPLAZO RENAL, NO ATB NI RECONEXION A VENTILACION MECANICA. Ademas se decide no realizacion de gastrostomia.

En este contexto se presenta a HSJM para traslado a unidad de cuidados paliativos dado no recuperabilidad neurologica de paciente.

Diagnóstico de Egreso

Meningitis - neumococica

Meningitis -

Condición de Egreso

Traslado

Egreso con Catéter Doble J:NO

Traslado a Hospital san José

Plan Post Alta

-Nutrición enteral: Fresubin HP 60 cc/ hora

-Agua libre 40cc/hora

-Aseo bucal c/ 6 horas

-HGT c/ 12 horas

Fármacos:

-Fenobarbital 100mg comp c/ 24 horas por SNG

-Levetiracetam 1g (2 comp 500mg) c/ 12 horas x SNG

-Omeprazol 20mg c/ 24 horas x SNG

-Paracetamol 1g (2 comp 500mg) SOS máximo c/ 8 horas x SNG

Manejo: NO IOT, NO RCP, NO TRR, NO DVA, NO ATB

Indicaciones

Tipo de Reposo : Absoluto

Régimen Alimentario : Nutrición Enteral

Medicamentos : Paracetamol 500mg 1 Gr Cada 8 Horas Vo
Omeprazol 20mg 20 Mg/Día

Fecha Epicrisis : 07/02/2026 07:53

Página 2 de 3



Epicrisis Hospitalaria

ESTADO: DEFINITIVA



COMPLEJO ASISTENCIAL

DR. SÓTERO DEL RÍO

JUNTOS PARA UNA MEJOR SALUD

Fecha Última Actualización: 07-02-2026 7:53:10

Página 3 de 3

Levetiracetam 1 Gr 1 Gr Cada 12 Horas

Fenobarbital 100 Mg 100 Mg/Día

Controles

INTERNO

Becado/Residente

Claudia Beatriz Espinoza Casado

Médico Tratante (Staff)